

05 - Développement psychoaffectif et sociale du Nourrisson

Bonjour, nous allons voir le développement psycho-affectif et social du nourrissement. Pour les objectifs du cours, il faut définir les principales caractéristiques de la communication mère-enfant, décrire les principales compétences sensorielles et sociales du nouveau-né qui entrent en jeu dans la communication mère-enfant, expliquer la notion de dyade et de phase symbiotique, définir la théorie d'attachement du nourrisson à sa mère selon Bowlby, expliquer le processus d'individuation et de séparation selon Malheur, décrire les différents niveaux d'interaction mère-enfant et les différentes étapes de prise de conscience de l'enfant de son état de sujet. Le développement psycho-affectif est inscrit dans le patrimoine génétique, donc l'expression des processus maturationnels apparaît étroitement impliquée dans l'interaction de l'organisme avec le milieu.

Le vécu des mamans durant la grossesse a une importance majeure dans le développement psycho-affectif du fœtus déjà, durant la grossesse et du nouveau-né après l'accouchement et durant les premières semaines de vie. La présence psychique et l'intégrité psychique de la maman jouent un rôle primordial dans les relations précoces et sur le développement ultérieur du nourrissement. La grossesse est considérée comme une période très vulnérable, une période de transparence psychique.

Au cours de la période, tous les événements antérieurs dans le passé de la mère vont refaire leur surface, ce qui la rendra encore plus vulnérable sur le plan psychique. Il y a aussi les angoisses et les préoccupations maternelles vis-à-vis de son rôle de mère, vis-à-vis de son enfant. Une autre source qui pourrait être une source d'angoisse, c'est les attentes de la maman vis-à-vis de l'enfant, l'enfant imaginaire, imaginé par l'enfant, et son adaptation avec l'enfant réel, qui peut parfois être très différent, ce qui peut engendrer des perturbations chez la maman.

L'échographie gestationnelle peut aussi angoisser la mère, puisque l'image de l'enfant allégorique ne correspond pas à la réalité, et pourrait être la cause de plusieurs interprétations de la maman, et plusieurs peurs vis-à-vis de son enfant. Les interactions entre la mère et l'enfant sont très importantes, surtout les interactions précoces. Déjà, à la naissance, il existe un lien entre la maman et le nouveau-né.

La mère peut construire un lien d'attachement d'emblée avec le nouveau-né. Ce dernier peut faciliter la tâche, puisque lui-même peut stimuler la maman, et encourager son attention et les soins qu'elle va lui produire. Selon Minécote, un nouveau-né ne peut pas exister sans sa mère, ce qui souligne l'importance de la relation mère-enfant.

Le potentiel inné de l'enfant ne peut s'exprimer que grâce aux soins de la maman, c'est-à-dire que c'est elle qui va le stimuler, qui va l'encourager, le motiver, pour que lui aussi soit un acteur positif dans l'établissement du lien. Plusieurs facteurs peuvent favoriser l'établissement d'une bonne relation entre la maman et l'enfant. Par exemple, la disponibilité affective de la mère, la

souplesse de ses réponses, sa stabilité, sa continuité, sa cohérence dans la relation.

Les compétences du nouveau-né sont aussi très importantes dans l'établissement. Les états de vigilance, c'est-à-dire l'état d'éveil du nouveau-né, au cours duquel le bébé a des capacités à percevoir et discriminer les informations de l'environnement, sont très importants. C'est durant ces états d'éveil et de vigilance que le bébé exerce un contrôle et une influence sur son environnement, d'où la valeur affective de la relation.

Les compétences sensorielles du nouveau-né sont aussi importantes. Visuelle, c'est-à-dire que le nouveau-né aura des perceptions qui existent dès la naissance. L'accommodation va apparaître et être parfaite en trois mois et demi.

Une bonne acuité visuelle favorise l'interaction du nouveau-né avec son environnement et l'encourage à interagir de bonne qualité. Les compétences auditives également sont importantes, puisqu'il va reconnaître la voix de sa maman en premier lieu, puis les différentes voix humaines et les bruits de son entourage. Les compétences olfactives, le bébé reconnaît déjà l'odeur de sa mère à la naissance, ce qui l'aide à la reconnaître et aide aussi à l'établissement du lien précoce.

Le toucher est aussi un élément important, puisque la première expérience du nouveau-né dès la naissance, c'est le corps à corps avec sa maman, ce qui va lui permettre de toucher la peau de sa maman ou de la sentir. C'est un élément très important pour commencer à établir le lien dès la naissance. Dès la douzième heure de naissance, le nouveau-né possède déjà des compétences sociales.

On observe un rythme coordonné des mouvements du nouveau-né selon la voix humaine, une interaction spécifique à la voix de sa maman. Le nouveau-né commence déjà à réagir au stimuli extérieur et il va rapidement être capable d'imiter les autres. La diade mère-enfant se construit très tôt par la série d'échanges entre les deux.

Les échanges se font au moment des soins, au moment des tétés, c'est un stade très important. Même si le nouveau-né ne distingue pas encore la différence entre lui et sa mère, on va dire qu'ils sont dans un état fusionnel. Les soins jouent le rôle d'un mot auxiliaire de l'enfant.

Le maternage et les soins apportés au nouveau-né l'aident à développer ses perceptions sensorielles. Le sourire est le prototype des relations sociales du bébé avec son entourage. C'est l'indice du fonctionnement de la diade mère-enfant.

La théorie de l'attachement a été établie par John Bolvi. Pour lui, l'attachement est la propension à établir des liens forts avec des personnes particulières, notamment les principales figures d'attachement. L'attachement existe dès la naissance et se maintient tout au long de la vie.

C'est-à-dire qu'il souligne vraiment l'importance des liens précoces et de la qualité de l'attachement parce que c'est une chose qui va durer toute la vie et qui va influencer le

comportement et la personnalité de l'individu. Tout l'attachement se développe à partir du comportement inné, du horizon, les pleurs, la chuchot, l'agrippement. Ceci lui permet de maintenir la proximité physique et l'accessibilité à la figure d'attachement, qui est principalement la mère.

En fonction de la qualité de l'attachement, l'enfant va se sentir protégé, réconforté. Il va se consoler auprès de sa figure d'attachement quand il va sentir ou percevoir une menace extérieure. On distingue l'attachement sécure de l'attachement non-sécure.

L'attachement sécure se développe quand les réponses de l'entourage sont adéquates aux besoins de l'enfant. L'enfant va développer une base de sécurité, une image de lui-même positive et de nouvelles compétences peuvent apparaître. Puisque les réponses sont adéquates, l'enfant se sent digne d'être aimé.

Il a une certaine estime de soi qui va se développer et il sera capable de se séparer de façon saine de sa figure d'attachement pour aller explorer l'environnement. Pour l'attachement non-sécure, il se produit quand les réponses de l'entourage aux besoins de l'attachement sont inadéquates. Par exemple, on aura des mères qui sont rejetantes ou des mères violentes vis-à-vis de l'enfant.

L'enfant va se sentir mal aimé, il va être dans l'évitement. On aura un attachement qui est angoissé et ambivalent, évitant ou désorganisé. Ceci va impacter l'image de soi de l'enfant, ce qui va conduire vers des troubles psychiques par la suite.

Comme on avait expliqué, l'enfant va faire des demandes, il va exprimer à partir des cris. Il va s'attendre à avoir des réponses de son entourage. Quand les réponses sont cohérentes, quand la figure d'attachement est contenante, quand elle est rassurante, l'enfant va se sentir stable et en sécurité.

Il pourra ainsi explorer le monde et construire ses connaissances en toute sécurité. Pour les niveaux d'interaction mère-enfant, dans la préoccupation maternelle primaire, il s'agit de la capacité d'empathie qu'a la mère envers son enfant. Elle le regarde grâce à ses capacités d'empathie.

Elle ressent et perçoit la signification des mots et des gestes de ses enfants. On a les interactions comportementales. Elles signifient les comportements réciproques entre la maman et son nourrisson.

Par exemple, le nourrisson qui va regarder la maman, qui va lui sourire, qui va crier, qui va l'attraper. Et en retour, c'est la réponse comportementale de la maman qui va s'en suivre. Pour les interactions corporelles et cutanées, ils signifient l'ensemble des échanges médiatisés par la façon dont l'enfant est tenu, la façon dont la maman étient son enfant, la façon dont elle le porte, la façon dont elle le change, dont elle lui fait des soins corporels.

Il y a aussi la qualité des contacts peau à peau qui sont très importants. Au moment des soins, les caresses, les chatouillements, les bisous que va donner la maman à son bébé. Le sourire est le principal symbole des interactions affectives de l'enfant, du nourrisson.

Il apparaît dès le troisième mois de vie. C'est un comportement très efficace et gratifiant. Le bébé va regarder la maman, lui sourire.

Ceci va stimuler la maman, va la motiver. C'est vraiment un signe très important qu'apporte le nourrisson à sa maman. Les interactions fantasmatiques désignent tous les aspects inconscients de la relation mère-enfant.

C'est la vie imaginaire et fantasmatique de la maman qui va se projeter sur son enfant. Ceci nous renvoie vers l'enfant imaginaire, l'enfant rêvé par la maman. Winnicott introduit la notion de sécurité par le holding et le handling.

Le holding est un terme qui désigne la façon dont l'enfant est porté physiquement et psychiquement par la maman. Il s'agit d'une contenance psychique, d'un sentiment d'unité de soi qui vise à protéger l'enfant. Le handling, quant à lui, fait référence aux manipulations du corps et aux différents soins apportés par la maman.

C'est-à-dire les soins mécaniques, le changement, le laver, le toucher. Il permet à l'enfant de lier son vécu corporel à son vécu psychique. L'objet présentiel fait référence à la capacité de la maman de mettre à disposition de l'enfant les objets au moment opportun.

C'est-à-dire, ça va mettre le point sur la façon avec laquelle la maman comprend les sollicitations et les exigences de son enfant. Le processus de séparation et d'individuation par Marguerite Mahler, c'est un processus psychique qui permet le développement de l'image corporelle chez l'enfant et du sentiment de conscience de soi. Ce concept distingue la naissance biologique de la naissance psychologique, qui sont différentes.

Ce processus évolue au gré des différentes acquisitions de l'enfant, notamment l'utilisation d'un objet transitionnaire, le déplacement autonome avec éloignement grâce à la marche, l'exploration de l'espace et des objets, l'utilisation du langage, le jeu symbolique, la découverte de la différence des sexes, l'angoisse du 8ème mois. L'enfant éprouve une angoisse lors de l'absence de sa maman. L'objet transitionnel, c'est-à-dire que l'enfant va utiliser un objet pour apaiser son angoisse lors de la séparation avec la maman.

Il permet à l'enfant de gérer les séparations et de renforcer son sentiment d'estime de soi. Le stade des essais. Tout en restant dans une proximité physique rassurante, l'enfant se sent inconfortable dans la relation symbiotique avec sa maman durant cette période.

Il va commencer à s'éloigner de la maman par un ensemble de déplacements qui correspond à ses capacités motrices acquises à ce moment. L'activité motrice de l'enfant, constamment

améliorée, joue un rôle fondamental dans l'évolution de la relation avec sa maman. Le stade du rapprochement.

À ce stade, la peur de l'enfant de perdre l'amour de sa mère devient évidente. C'est une période marquée par l'instabilité de l'humeur, par des mouvements alternatifs de rapprochement et d'éloignement. C'est le stade où la sphère sociale s'élargit.

Il va dépasser la maman vers le père, vers les autres membres de la famille. L'acquisition du schéma corporel se fait entre 4 et 6 mois. L'enfant ne se reconnaît pas devant un miroir.

Entre 6 et 8 mois, il découvre que l'autre enfant dans le miroir n'est qu'une image et non un être réel. À travers la fonction du miroir que la mère offre à son enfant, dans les échanges relationnels, une distinction entre soi et non-soi s'amorce. C'est la maman qui va apprendre à l'enfant les différentes parties de soi.

Vers un an, il comprend que l'image du miroir, c'est son propre corps. Il le perçoit comme un tout et s'identifie à l'image réfléchie.